THAMYRES TOSARELLI

FACETA DIRETA EM RESINA COMPOSTA

Trabalho de Conclusão de Curso

Primeira parte: Introdução, Objetivos e Revisão de Literatura

2026

1 INTRODUÇÃO

A aparência do sorriso tem um peso cada vez maior na forma como as pessoas se veem e são vistas. Soares e Borges (2023) observaram que a estética dental passou a ser procurada não só por saúde, mas também por autoestima, aceitação social e bem-estar, e que essa procura cresceu bastante com a influência das redes sociais. Rocha et al. (2021) explicaram que dentes com alteração de cor, forma ou posição costumam ser percebidos como fora do padrão divulgado pela mídia, o que pode gerar insegurança, timidez e até isolamento, levando o paciente ao consultório em busca de uma solução. Bento et al. (2021) mostraram que esse impacto não é apenas subjetivo: no caso relatado pelos autores, a qualidade de vida do paciente, medida pelo questionário OHIP-14, melhorou de forma clara após o tratamento estético.

Silva, I. et al. (2021) apontaram que as queixas mais frequentes dos pacientes envolvem a cor dos dentes, o contorno inadequado e a presença de diastemas, e que, para resolvê-las, o cirurgião-dentista pode indicar clareamento dental, tratamento ortodôntico, laminados cerâmicos ou facetas diretas em resina composta, muitas vezes combinando essas opções. Lima et al. (2020) destacaram que, no caso dos diastemas, as restaurações diretas oferecem tempo reduzido de trabalho, baixo custo e resultado imediato.

Alves, Peres e Lima (2022) e Brito, Ferreira e Yamashita (2022) descreveram as facetas como procedimentos que recobrem a face vestibular dos dentes para melhorar sua estética e função, podendo ser confeccionadas de forma direta, com resina composta aplicada no próprio consultório, ou de forma indireta, com peças de cerâmica ou de resina produzidas em laboratório. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) e Soares e Borges (2023) destacaram as vantagens da técnica direta: exige pouco ou nenhum desgaste do dente, pode ser concluída em uma única sessão, dispensa etapas laboratoriais, tem custo menor e permite reparos dentro da boca.

Boa parte dessa popularidade se deve à evolução das próprias resinas compostas. Lanzaretti et al. (2025) e Dominguez et al. (2024) relataram que os materiais nano-híbridos e nanoparticulados melhoraram o polimento, a resistência e a estabilidade de cor, permitindo restaurações cada vez mais próximas do dente natural. Nalbandian e Millar (2009), em um estudo com pacientes tratados com facetas de resina ou de porcelana, não encontraram diferença na melhora estética

percebida pelos próprios pacientes entre os dois materiais, o que reforça a resina como uma alternativa válida e mais conservadora.

Por outro lado, a técnica não está livre de problemas. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) lembraram que as facetas diretas são mais suscetíveis ao desgaste, ao manchamento e à fratura, e Cruz et al. (2023) apontaram que grande parte das falhas está ligada à execução do profissional e a fatores do próprio paciente, como hábitos parafuncionais e higiene deficiente. Reis et al. (2018) mostraram que o sucesso também depende de um bom planejamento, com recursos como o enceramento diagnóstico e o mock-up, e Santos et al. (2022) alertaram para o respeito aos tecidos periodontais, já que facetas mal adaptadas podem causar inflamação gengival.

Mesmo sendo um tratamento muito difundido, a literatura ainda não chegou a um consenso sobre a durabilidade das facetas diretas quando comparadas às indiretas. Galvão et al. (2025), em uma revisão sistemática recente, apontaram maior sobrevida para as facetas diretas, enquanto Teixeira et al. (2022) observaram vantagem das facetas indiretas de porcelana. Diante disso, torna-se importante reunir o que os estudos mostram sobre as indicações, a técnica, o planejamento e a longevidade das facetas diretas em resina composta, para que o cirurgião-dentista possa indicá-las com segurança e executá-las com previsibilidade.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Realizar uma revisão de literatura sobre as facetas diretas em resina composta em dentes anteriores, abordando suas indicações, a técnica de confecção, o planejamento e a longevidade clínica.

2.2 Objetivos específicos

a) contextualizar a busca pela estética do sorriso e a evolução dos materiais restauradores estéticos;
b) descrever a composição, a classificação, as propriedades e o desempenho das resinas compostas, bem como os princípios dos sistemas adesivos;
c) apresentar o conceito, as indicações, as contraindicações, as vantagens e as desvantagens das facetas diretas em resina composta, comparando-as com as facetas indiretas;
d) descrever as etapas de planejamento e a técnica de confecção das facetas diretas, incluindo o acabamento e o polimento;
e) discutir a relação entre as facetas diretas e os tecidos periodontais;
f) analisar a longevidade, as principais falhas e a manutenção das facetas diretas.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 A estética do sorriso

O sorriso é considerado um dos recursos mais importantes da expressão facial. Silva, I. et al. (2021) relataram que, a partir da década de 1990, houve um aumento claro na valorização da estética dental, associada à presença de dentes brancos, alinhados e bem contornados, padrão que já era registrado na literatura da época como sinônimo de beleza. Segundo esses autores, um sorriso agradável transmite harmonia, admiração e simpatia, e a sua ausência pode ser interpretada de forma negativa nas interações sociais. Eles citam ainda estudos sobre microexpressões faciais que mostram que um sorriso aberto, com os dentes à mostra, costuma ser interpretado como sinal de confiança, e que pessoas com sorriso agradável são vistas como mais confiantes e sociáveis, tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Silva, I. et al. (2021) também explicaram que a harmonia do sorriso depende da simetria dos dentes entre si e com a linha média da face, em equilíbrio com a gengiva, os lábios e o rosto. Assim, assimetrias de tamanho, espaçamento ou coloração criam uma aparência desagradável e prejudicam a forma como o paciente percebe a própria imagem. Vookanti et al. (2026) complementaram essa ideia ao listar os principais determinantes estéticos de um sorriso: forma e contorno dos dentes, simetria e proporção, alinhamento, textura de superfície, cor e translucidez, sempre aliados a uma função e uma fonética adequadas.

Essa valorização ganhou ainda mais força nos últimos anos. Soares e Borges (2023) observaram que a odontologia estética cresceu muito com a influência das redes sociais e que a aparência passou a ser um determinante da autoestima, fazendo com que a estética dental seja procurada por saúde, aceitação social e bem-estar. Rocha et al. (2021) acrescentaram que a falta de harmonia no sorriso pode gerar ansiedade, insegurança, timidez e até isolamento social, e que grande parte dos pacientes busca tratamentos que influenciem a sua autoimagem, seja por vaidade, seja por aceitação social, e não apenas o restabelecimento da função. Lanzaretti et al. (2025) também destacaram que a estética do sorriso tem grande influência nas relações sociais, na autoestima e na forma como cada pessoa se vê.

Ao mesmo tempo, o conceito de beleza não é igual para todos. Santos et al. (2022) lembraram que a estética é algo altamente subjetivo, pois está diretamente relacionada aos fatores sociais, culturais e psicológicos em que cada indivíduo está inserido. Por isso, ouvir as expectativas do paciente é tão importante quanto avaliar seus dentes.

Algumas alterações de forma, mesmo sem comprometer a saúde bucal, têm grande impacto na estética. Lanzaretti et al. (2025) citaram como exemplo os incisivos laterais conoides, que podem atingir até 2,5% da população e costumam vir acompanhados de diastemas e assimetrias que levam o paciente a procurar tratamento. Bento et al. (2021) mediram o impacto desse tipo de correção na vida do paciente aplicando o questionário de qualidade de vida OHIP-14 antes e depois de uma reabilitação com facetas diretas, e a pontuação caiu de 24 para 5 pontos, o que indica uma melhora importante na qualidade de vida relacionada à saúde bucal.

Por isso, o planejamento estético não pode olhar apenas para os dentes. Dominguez et al. (2024) destacaram que a simetria facial, as proporções dentárias, a linha do sorriso e a exposição gengival devem ser consideradas para definir o tratamento mais adequado, e Cruz et al. (2023) reforçaram que a análise deve incluir a face, os lábios, os materiais e as técnicas que serão empregados para que o resultado seja harmonioso e natural.

3.2 Evolução dos materiais restauradores estéticos

A preocupação em melhorar a aparência dos dentes não é recente. Alves, Peres e Lima (2022) relataram que as facetas surgiram na década de 1930, quando Charles Pincus as desenvolveu para realçar o sorriso de atores americanos. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) lembraram, porém, que durante muito tempo as opções foram limitadas e que, no começo do século XX, a maior parte dos procedimentos odontológicos se resumia a extrações. Só aos poucos o mercado odontológico evoluiu e surgiram materiais capazes de devolver estética e função.

Lanzaretti et al. (2025) relataram que as primeiras restaurações estéticas eram feitas com cimentos de silicato e, no início da década de 1950, passaram a ser feitas com resinas acrílicas de polimetilmetacrilato. Nessa época, segundo os autores, as restaurações posteriores ainda eram feitas quase sempre com

amálgama, e os materiais estéticos ficavam reservados aos dentes anteriores, onde a aparência era prioridade.

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) e Lanzaretti et al. (2025) destacaram que, no mesmo período, Buonocore desenvolveu a técnica do condicionamento ácido do esmalte com ácido fosfórico, que permitiu unir a restauração ao dente e selar suas margens, sendo considerada um marco para a odontologia adesiva. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) acrescentaram que, em 1956, Bowen introduziu o Bis-GMA, monômero que melhorou as propriedades das resinas e ampliou suas indicações, e que, a partir da década de 1970, as resinas passaram por mudanças nas partículas de carga. Os mesmos autores apontaram que a chegada dos aparelhos fotopolimerizadores também teve grande influência na evolução desses materiais.

Alves, Peres e Lima (2022) relataram que as resinas compostas foram introduzidas há cerca de 50 anos e que, desde então, sua composição evoluiu muito. Cruz et al. (2023) reforçaram que esses materiais estão presentes na clínica há mais de cinco décadas e que a melhora contínua da sua composição permitiu ampliar suas indicações, inclusive para resolver problemas estéticos. Alves, Peres e Lima (2022) observaram ainda que a técnica de estratificação com fins estéticos ganhou força com o desenvolvimento da fotopolimerização e com o lançamento de sistemas de resina que ofereciam diferentes opacidades.

Nalbandian e Millar (2009) lembraram que as primeiras facetas diretas em resina, usadas no fim da década de 1970 e início da de 1980, decepcionaram por apresentarem pouca estabilidade de cor, perda do polimento e desgaste, mas que as resinas atuais têm propriedades físicas e estéticas muito superiores, o que permite tratamentos minimamente invasivos com resultado imediato. Para Silva, I. et al. (2021), essa evolução foi especialmente marcante nos últimos 20 anos, com resinas de melhores propriedades mecânicas, físicas e ópticas e sistemas adesivos com maior capacidade de união ao dente.

Cruz et al. (2023) apontaram como um passo importante dessa evolução as resinas nano-híbridas e nanoparticuladas, que surgiram em meados dos anos 2000 com resistência semelhante à das micro-híbridas e polimento semelhante ao das microparticuladas, sendo muitas vezes chamadas de resinas universais. Mais recentemente, Teixeira et al. (2022) relataram a chegada ao mercado das facetas pré-fabricadas de resina composta, feitas de resina híbrida pré-polimerizada e cimentadas com a mesma resina, formando um conjunto único com o dente. Mesmo

com esses avanços, Alves, Peres e Lima (2022) ressaltaram que as resinas ainda apresentam limitações, como a contração de volume durante a polimerização e o estresse gerado por ela.

3.3 Resinas compostas

3.3.1 Composição e classificação

Soares e Borges (2023) explicaram que as resinas compostas são formadas por uma matriz orgânica, uma parte inorgânica, um sistema iniciador e um agente de união, sendo a matriz orgânica composta por monômeros que se transformam em polímeros durante a polimerização. Segundo esses autores, as resinas podem ser diferenciadas pelo tamanho e pelo tipo das partículas de carga e da matriz. Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que a resina composta tem propriedades semelhantes às do esmalte, e Cruz et al. (2023) destacaram que ela oferece grande variedade de cores e reproduz propriedades como translucidez, opalescência e fluorescência.

Cruz et al. (2023) explicaram que a classificação das resinas se baseia no tamanho médio das partículas de carga, na viscosidade e na forma de ativação. Quanto ao tamanho das partículas, elas podem ser macroparticuladas, microparticuladas, micro-híbridas (ou híbridas) e nanoparticuladas, e há ainda as resinas supra-nano, com partículas próximas de 200 nanômetros e comportamento parecido com o das nanoparticuladas. Quanto à viscosidade, podem ser de baixa, média ou alta, sendo a maioria das resinas atuais de viscosidade média, e quanto à ativação, podem ser fotoativadas ou ativadas quimicamente.

Cada tipo tem um comportamento diferente. Dominguez et al. (2024) relataram que as resinas microparticuladas oferecem acabamento superior e são fáceis de manipular, mas têm menor resistência mecânica, o que limita seu uso em áreas de grande esforço mastigatório, enquanto as nano-híbridas, por combinarem nanopartículas com partículas maiores, mantêm um polimento duradouro e resistem melhor ao desgaste e à fratura. Soares e Borges (2023) explicaram que, nas nanoparticuladas, as partículas chegam a 0,02 µm, o que proporciona superfície ainda mais lisa, ótimo brilho e boas propriedades mecânicas. Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que essas resinas de última geração reproduzem bem a fluorescência e a opacidade do dente, têm alta resistência à fratura e ao desgaste, menor contração de polimerização e boa estabilidade de cor.

Para as facetas, Cruz et al. (2023) afirmaram que a resina precisa ter boa lisura de superfície, bom escoamento, variedade de cores, estabilidade e bom acabamento, características encontradas nas resinas microparticuladas, nanoparticuladas e nano-híbridas. Segundo os autores, as microparticuladas têm alto grau de polimento, mas resistência limitada quando é preciso reconstruir grandes volumes, enquanto as micro-híbridas têm boa resistência e polimento inferior, sendo recomendadas para alongamentos dentais e para a reconstrução da face palatina. Alves, Peres e Lima (2022) lembraram que escolher a resina exige equilibrar vários requisitos, como longevidade, resistência, tenacidade à fratura, dureza superficial, módulo de elasticidade adequado, baixo desgaste e baixa degradação.

Na prática, a escolha depende da situação clínica. Lima et al. (2020) indicaram a resina microparticulada como material de eleição para fechar diastemas de até 2 mm, pelo polimento semelhante ao do esmalte e pela translucidez, e justificaram o uso das nano-híbridas por unirem bom polimento à resistência das resinas híbridas, graças ao alto conteúdo de carga. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) também observaram que as resinas microparticuladas e nanoparticuladas ficam com superfície mais lisa após o polimento do que as micro-híbridas e que as nanoparticuladas se degradam menos na cavidade bucal, o que favorece a estética e a longevidade em dentes anteriores. Teixeira et al. (2022) lembraram, por fim, que a escolha também depende da preferência do clínico, mas que ele precisa conhecer as diferentes composições e propriedades de cada material.

3.3.2 Propriedades

Dominguez et al. (2024) afirmaram que conhecer as propriedades da resina é fundamental para decidir se ela é adequada para as facetas. A principal preocupação, segundo os autores, é a contração de polimerização: durante a reação, o material sofre uma contração de volume que pode causar microinfiltração nas margens, sensibilidade pós-operatória e falhas na restauração, e cada formulação de resina apresenta uma taxa diferente de contração, o que reforça a importância de escolher bem o material.

Os mesmos autores destacaram outras propriedades importantes. A resistência à abrasão é essencial para que a faceta mantenha a estética ao longo do

tempo e depende do tamanho e da distribuição das partículas de carga. O módulo de elasticidade mede a rigidez do material, e uma resina com módulo parecido com o do dente ajuda a aliviar as tensões na interface entre o dente e a restauração, reduzindo o risco de fratura. Já o coeficiente de expansão térmica indica o quanto o material se expande ou se contrai com as variações de temperatura, e quanto mais próximo ele for do dente, menor o risco de microinfiltração e de fraturas.

A forma de polimerizar também interfere nessas propriedades. Cruz et al. (2023) explicaram que falhas na fotoativação podem reduzir o grau de conversão da resina, provocando alterações de cor, maior desgaste superficial, maior chance de infiltração marginal, altos níveis de monômero residual e piora das propriedades mecânicas. Por isso, Alves, Peres e Lima (2022) e Cruz et al. (2023) destacaram que a escolha correta da resina, do sistema adesivo e do aparelho fotopolimerizador é fundamental para o sucesso das restaurações em dentes anteriores.

3.3.3 Desempenho clínico e laboratorial

As diferenças entre os tipos de resina aparecem também na boca. Irgang et al. (2020) avaliaram retrospectivamente 74 facetas diretas em 28 pacientes, com média de idade de 42,9 anos e média de três anos de uso, variando de seis meses a dez anos, comparando resinas microparticuladas e universais por meio dos critérios FDI e USPHS. A taxa de sobrevivência foi de 77%, com 17 falhas no total, e as três perdas completas ocorreram no grupo das universais. As microparticuladas tiveram melhor desempenho em brilho, manchamento superficial, correspondência de cor e adaptação marginal, confirmando na clínica a vantagem estética descrita pelos autores citados anteriormente. Os dois critérios de avaliação apresentaram resultados semelhantes.

Resinas mais recentes também vêm mostrando bons resultados. Bastos et al. (2018) acompanharam por seis meses facetas diretas feitas com uma resina de carga supra-nano esférica, na cor A1 para dentina e esmalte, em uma paciente de 39 anos com dentes escurecidos pelo uso de medicamentos e com bruxismo. Ao final do período, as restaurações tinham bom aspecto clínico, sem acúmulo de biofilme nem desgaste abrasivo, o que, segundo os autores, sugere um desempenho promissor desse tipo de material.

Fernandes et al. (2022) compararam em laboratório a microdureza das resinas Filtek Z350 XT e Filtek One Bulk Fill polimerizadas pela técnica imediata ou pela técnica de pulso tardio. Foram utilizados 40 corpos de prova, divididos em quatro grupos de dez, armazenados em água destilada e depois submetidos ao teste de microdureza. A técnica imediata produziu dureza significativamente maior, e a Z350 XT foi mais dura que a bulk fill nas duas técnicas. Os autores lembraram que as técnicas alternativas de polimerização surgiram para diminuir o estresse de contração e o tempo de atendimento, mas concluíram que a técnica convencional ainda alcança maior dureza.

Os hábitos do paciente também pesam. Tozo-Burgos, Escalante-Otárola e Sánchez-Tito (2025) imergiram cinco resinas de alta translucidez (Filtek Z350 XT Translucent, Forma Trans, Palfique LX5, Beautifil II e Opallis T-Neutral) em uma bebida energética por dez minutos ao dia, durante 30 dias, mantendo-as em saliva artificial entre as imersões. Todas perderam dureza e ficaram mais rugosas com o tempo. A Filtek Z350 XT manteve a maior dureza, a Forma Trans foi a mais estável e a Beautifil II foi a mais afetada, levando os autores a concluir que materiais com nanoaglomerados e zircônia resistem melhor à degradação ácida. Esse resultado mostra que, além de escolher bem o material, o profissional precisa orientar o paciente sobre a dieta para preservar a faceta.

3.4 Sistemas adesivos

Toda faceta direta depende da adesão, já que a resina precisa ficar firmemente unida ao dente. Dominguez et al. (2024) afirmaram que uma ligação estável entre o material e a estrutura dental é fundamental para a longevidade da restauração e descreveram o condicionamento com ácido fosfórico como uma etapa essencial, pois remove a camada superficial de hidroxiapatita e cria uma superfície microrretentiva para a resina. Segundo os mesmos autores, o sistema adesivo funciona como uma ponte entre a resina e o dente, melhorando a união e selando as margens da restauração.

Dominguez et al. (2024) explicaram ainda que existem diversas gerações de sistemas adesivos, cada uma com seu próprio mecanismo de união, e citaram a teoria do monômero bifuncional, proposta por Bowen em 1965, segundo a qual os monômeros do adesivo penetram na estrutura dental e criam, ao mesmo tempo,

uma ligação com a superfície do dente e uma ancoragem mecânica para a resina. Alves, Peres e Lima (2022) destacaram que a adesão ao esmalte, por retenção micromecânica, é simples de obter e é a mais forte da cavidade bucal, o que permite preparos menores. Teixeira et al. (2022) reforçaram que a adesão ideal é alcançada quando o preparo fica totalmente em esmalte e quando o tratamento de superfície é feito corretamente.

A quantidade de esmalte é, por isso, um fator decisivo. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que dentes com menos de 50% de esmalte remanescente não têm boa indicação para facetas, porque a retenção fica deficiente e aumenta o risco de infiltração e descolamento.

Os protocolos descritos nos artigos são bastante parecidos. Alves, Peres e Lima (2022) relataram a aplicação de ácido fosfórico a 37% por 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina, lavagem por 20 segundos, secagem, duas aplicações do sistema adesivo e fotoativação por 40 segundos. Soares e Borges (2023) citaram um protocolo com condicionamento por 30 segundos no esmalte, lavagem por 60 segundos e adesivo universal fotoativado por 20 segundos. Silva, I. et al. (2021) chamaram essa etapa de hibridização do substrato e a posicionaram logo após os ajustes do mock-up. Galvão et al. (2025) observaram, em sua revisão sistemática, que a maioria dos estudos clínicos incluídos utilizou o sistema Clearfil SE Bond, considerado padrão-ouro na adesão ao esmalte e à dentina.

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) alertaram que a adesão precisa respeitar as propriedades químicas e físicas de cada produto, porque qualquer etapa mal executada pode comprometer a interface adesiva, e que falhas na adesão ou na fotopolimerização podem causar pigmentação dos materiais ou dos dentes. Nessa mesma linha, Lima et al. (2020) afirmaram que o sucesso das facetas depende de o cirurgião-dentista compreender os princípios básicos dos sistemas adesivos e das resinas atuais. Silva, I. et al. (2021) ressaltaram que foi justamente a evolução dos sistemas adesivos que tornou possível, em muitos casos, reabilitar os dentes com preparos mínimos ou sem desgaste algum, e Cruz et al. (2023) concluíram que vivemos hoje uma era de preservação das estruturas saudáveis graças à evolução conjunta das resinas e dos adesivos.

3.5 Facetas diretas em resina composta

3.5.1 Conceito

Silva, I. et al. (2021), Brito, Ferreira e Yamashita (2022) e Cruz et al. (2023) definiram as facetas como restaurações que recobrem a face vestibular do dente com um material restaurador fixado por meio de sistemas adesivos, podendo ser confeccionadas de forma direta, com resina composta, ou indireta, com cerâmica ou resina processada fora da boca. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) explicaram que as facetas diretas são aplicadas sobre o dente diretamente no consultório, enquanto as indiretas são produzidas em laboratório e depois cimentadas com um adesivo resinoso. Dominguez et al. (2024) descreveram a faceta direta como uma restauração moldada e polida diretamente na boca do paciente, com um material que imita as propriedades ópticas e mecânicas do esmalte.

Cruz et al. (2023) destacaram que a faceta direta foi criada para preservar a maior quantidade possível de estrutura dental, aplicando uma ou mais camadas de resina sobre a superfície do dente para melhorar a estética e a função. Soares e Borges (2023) consideraram o procedimento menos invasivo, já que, na maioria dos casos, não exige preparo prévio, a não ser quando o dente precisa de ajustes de anatomia. Santos et al. (2022), porém, fizeram uma ressalva importante: embora as facetas diretas sejam mais conservadoras que as indiretas, elas não são a mais conservadora das restaurações diretas, devendo ser indicadas com critério.

3.5.2 Indicações

As facetas diretas podem resolver um grande número de problemas estéticos. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) listaram como indicações as alterações de cor e de forma, os dentes escurecidos ou manchados, a amelogênese imperfeita, as microdontias, as alterações de posição e as perdas de estrutura por desgaste, além de dentes girovertidos, fraturas extensas, má-formações e alterações da textura de superfície. Dominguez et al. (2024) acrescentaram as manchas, as fraturas e lascas, as irregularidades de forma e tamanho e o fechamento de espaços entre os dentes, e Cruz et al. (2023) incluíram o desalinhamento e as sequelas de cárie.

Alves, Peres e Lima (2022) explicaram que a resina é indicada para alterações de cor, forma e textura da face vestibular quando soluções mais

conservadoras não foram suficientes. Os mesmos autores observaram que pequenas discrepâncias de alinhamento levariam meses para serem corrigidas com ortodontia, enquanto problemas menores podem ser resolvidos de forma satisfatória com a técnica direta.

Os diastemas estão entre as indicações mais comuns. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) lembraram que, no adulto, o diastema dá ao sorriso um aspecto infantil e pode incomodar bastante o paciente, e que a resina consegue preencher esse espaço de forma rápida. Lima et al. (2020) consideraram as restaurações diretas uma opção de destaque para o fechamento de diastemas, e Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que, quando existe apenas uma pequena desproporção entre os dentes, as facetas podem substituir o tratamento ortodôntico com resultado mais rápido. Esses autores destacaram, no entanto, a importância do diagnóstico diferencial, avaliando idade, crescimento facial, tamanho dos dentes, inserção do freio labial e hábitos deletérios, já que diastemas maiores podem exigir ortodontia, cirurgia ou próteses.

Os relatos de caso mostram essa variedade na prática. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) utilizaram facetas diretas em três pacientes: um paciente de 37 anos com fratura das bordas incisais, outro com dentes escurecidos e um terceiro com uma restauração antiga deficiente. Dias et al. (2020) trataram manchas brancas lisas e brilhantes na região cervical dos dentes anteriores de uma paciente de 21 anos, diagnosticadas como lesões de cárie inativa, e Vookanti et al. (2026) usaram a técnica para mascarar as manchas brancas e acastanhadas da fluorose moderada. Lanzaretti et al. (2025) destacaram os incisivos laterais conoides como uma das alterações que mais levam o paciente a buscar as facetas diretas, e Rocha et al. (2021) relataram a reanatomização desses dentes com resina composta.

Os dentes escurecidos exigem uma atenção especial. Silva, I. et al. (2021) explicaram que manchas causadas por hemorragias ou restos pulpares costumam responder bem ao clareamento, mas que manchas por sais metálicos podem dificultar ou impedir o tratamento clareador, sendo necessário recorrer a outras técnicas restauradoras. Joshi (2025), em um dente desvitalizado e escurecido, realizou clareamento interno antes das facetas, enquanto Falcão et al. (2023), diante de um dente em que um novo clareamento interno estava contraindicado, recorreram a pigmentos opacificadores para bloquear o escurecimento. Soares e Borges (2023) explicaram que, nesses casos, o profissional pode aumentar o

desgaste do dente ou, de forma mais conservadora, usar opacificadores, que impedem a passagem da luz e mascaram a cor do substrato.

3.5.3 Contraindicações

Nem todo paciente é um bom candidato às facetas. Cruz et al. (2023) contraindicaram o tratamento em pacientes com doença periodontal grave, sobremordida acentuada, bruxismo e má higiene bucal. Santos et al. (2022) ampliaram essa lista, incluindo dentes sem suporte saudável, com menos de 50% de esmalte, muito vestibularizados, com múltiplas restaurações ou com grande giroversão, além de bruxismo não tratado, periodontite grave, oclusão topo a topo, mordida cruzada e apinhamento. Silva, I. et al. (2021) ressaltaram que cabe ao cirurgião-dentista analisar a viabilidade do tratamento com base nas indicações e contraindicações, planejando de forma individualizada para a realidade de cada paciente.

O bruxismo aparece em quase todos os trabalhos como um fator de risco. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) observaram que, em pacientes com bruxismo severo, as facetas de resina têm limitações funcionais e exigem manutenção para repolimento. Teixeira et al. (2022) relataram que o bruxismo também aumenta a taxa de insucesso das facetas indiretas e que os descolamentos são mais frequentes quando o paciente não usa a placa miorrelaxante recomendada. Dominguez et al. (2024) acrescentaram que hábitos como morder objetos duros, roer unhas ou usar os dentes como ferramenta também aumentam o risco de danos às facetas.

3.5.4 Vantagens e desvantagens

As vantagens das facetas diretas são citadas de forma muito parecida pelos autores. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) destacaram a ausência de preparo ou o preparo mínimo, o menor custo, a reversibilidade, a dispensa de cimentação, o polimento fácil, a possibilidade de reparar trincas e fraturas na boca e a melhor adaptação marginal em relação às facetas indiretas. Silva, I. et al. (2021) acrescentaram a possibilidade de concluir o tratamento em uma única sessão, a boa resiliência do material e a ausência de provisórios, e Cruz et al. (2023) consideraram a técnica mais conservadora, mais barata e mais rápida que as facetas cerâmicas, por não depender de etapa laboratorial.

Dominguez et al. (2024) reforçaram que a principal vantagem é a conservação da estrutura dental saudável, já que, ao contrário das facetas de porcelana, as de resina podem ser feitas com preparo mínimo ou sem desgaste algum, preservando inclusive a vitalidade pulpar. Os autores destacaram ainda a ampla variedade de cores e opacidades, que permite corrigir manchas, descolorações e irregularidades com resultado natural, e a união micromecânica com o dente. Alves, Peres e Lima (2022) ressaltaram a capacidade da resina de reproduzir morfologia, cor, translucidez e opacidade, e Brito, Ferreira e Yamashita (2022) citaram a mínima agressão ao periodonto e o bom custo-benefício tanto para o paciente quanto para o profissional.

As desvantagens, por outro lado, estão ligadas principalmente ao material. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) apontaram a menor resistência ao desgaste e a maior suscetibilidade ao manchamento e às fraturas. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) citaram a perda de brilho e o amarelamento mais rápido, e Silva, I. et al. (2021) explicaram que a instabilidade de cor ao longo do tempo está ligada à composição da resina, de base plástica associada a partículas vítreas, podendo ocorrer também microinfiltrações. Dominguez et al. (2024) observaram que o manchamento e o desgaste são maiores em pacientes que consomem alimentos e bebidas pigmentados, fumam ou têm higiene deficiente. Teixeira et al. (2022) relataram ainda descolamento, desgaste e fendas marginais, e Lanzaretti et al. (2025) apontaram a necessidade de manutenção periódica.

Silva, I. et al. (2021) lembraram que a técnica também exige muito do profissional, pois depende de habilidade manual, de um olhar atento na escolha da cor e de cuidado no acabamento e no polimento. Alves, Peres e Lima (2022) observaram que a resistência mecânica das facetas diretas pode ser inferior à das restaurações indiretas.

3.5.5 Facetas diretas e indiretas

Para entender o lugar das facetas diretas, é importante compará-las com as indiretas. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que as facetas indiretas são uma alternativa protética para modificar a forma, a posição (em pequenas correções) e a cor dos dentes, corrigir defeitos estruturais e reabilitar a oclusão. Entre suas vantagens, os autores citaram a fabricação fora da boca, que permite melhor

visualização e detalhamento anatômico. Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que a técnica indireta é uma boa alternativa para profissionais sem tanta habilidade manual com a resina, já que as peças são produzidas em laboratório, mas que ela tem custo maior, exige mais sessões e depende de cimentação.

Silva, I. et al. (2021) também descreveram os laminados cerâmicos, que recobrem apenas a face vestibular com espessura menor que a das facetas convencionais, permitindo preparos restritos ao esmalte. Os autores alertaram, porém, que, dependendo da espessura e da cor do substrato, os laminados têm dificuldade para mascarar dentes escurecidos, e que são contraindicados em dentes muito escurecidos, com restaurações extensas, em pacientes com bruxismo, vestibularização severa ou doença periodontal grave. Teixeira et al. (2022) lembraram que as cerâmicas também têm desvantagens, como baixa resistência à tração, fragilidade e etapas laboratoriais demoradas.

Lanzaretti et al. (2025) compararam o tempo de cadeira das duas técnicas: os laminados exigem preparo, ainda que mínimo, moldagem, provisório e uma consulta a mais para a cimentação, enquanto as facetas diretas precisam apenas de um enceramento diagnóstico, digital ou tradicional, e de uma sessão restauradora. Por isso, os autores consideraram as facetas diretas especialmente interessantes para pacientes jovens. Alves, Peres e Lima (2022) apresentaram uma comparação em que a resina se destaca pela preservação do dente e pelo menor custo, e a cerâmica, pela estabilidade de cor.

Do ponto de vista do paciente, a diferença entre os dois materiais parece pequena. Nalbandian e Millar (2009) compararam a opinião de 96 pacientes, entre 145 consultados, tratados com dez facetas de resina ou dez de porcelana, por meio de escalas visuais que avaliavam cor, forma, tamanho, linha do sorriso e aparência facial antes e depois do tratamento. Não houve diferença na melhora estética percebida entre os dois materiais, e a conservação do dente, o tempo de tratamento e os custos de reparo e substituição favoreceram a resina. Os autores concluíram que, quando bem informados, os pacientes podem preferir a opção mais conservadora.

Em alguns casos, os dois materiais podem ser combinados. Vaz, Lopes e Toledo Neta (2022) relataram o caso de uma paciente de 21 anos com desalinhamento dos dentes anteriores, em que a reabilitação estética foi usada como alternativa à ortodontia, com cerâmica de dissilicato de lítio nos seis dentes

anteriores e resina composta Z350 XT nos pré-molares. Os autores concluíram que a associação de diferentes materiais corrigiu o alinhamento e devolveu estética e função.

3.6 Planejamento

Os autores concordam que o resultado de uma faceta direta é definido, em grande parte, antes de se aplicar a resina. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que o planejamento deve envolver não só a necessidade estética, mas também a saúde bucal do paciente, com uma consulta minuciosa para identificar lesões de cárie, doença periodontal ou necessidade de tratamento endodôntico. Cruz et al. (2023) e Silva, I. et al. (2021) detalharam que o exame clínico deve verificar restaurações prévias insatisfatórias, lesões cariosas e periapicais, com radiografias e teste de vitalidade, e Silva, I. et al. (2021) recomendaram ainda o registro fotográfico da situação inicial para comparação com o resultado final.

Dominguez et al. (2024) afirmaram que o planejamento estético deve começar por uma análise detalhada da face e do sorriso, considerando a simetria facial, as proporções dentárias, a linha do sorriso e a exposição gengival, e que a forma ideal dos dentes anteriores deve ser definida a partir do comprimento, da largura e da forma da borda incisal. Os autores citaram ainda o uso de princípios como a proporção áurea para orientar esse planejamento.

Silva, I. et al. (2021) explicaram que, após o exame, é feita a moldagem com alginato para obter os modelos de estudo e o enceramento diagnóstico, que, em alguns casos, são montados em articulador semiajustável. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) definiram o enceramento como uma reprodução dos dentes em cera que permite avaliar a anatomia, orientar o preparo e mostrar o resultado final ao paciente, e destacaram que ele deve reproduzir proporção dentária, pontos de contato, arquitetura gengival, bordas incisais, inclinação axial e zênites gengivais. Lanzaretti et al. (2025) recomendaram fotografias intra e extraorais e modelos de estudo como base para o enceramento, e Dominguez et al. (2024) destacaram seu papel na comunicação entre o dentista e o paciente.

A partir do enceramento, é possível fazer o mock-up, um ensaio restaurador na boca do paciente. Cruz et al. (2023) explicaram que o mock-up é totalmente reversível e feito diretamente sobre os dentes com resina bisacrílica, um material de

base e catalisador em pontas de automistura, ativado quimicamente. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) reforçaram que, sem o mock-up, o profissional tem dificuldade para visualizar a forma, a posição e a proporção das futuras restaurações. Reis et al. (2018) relataram um caso em que o mock-up foi ajustado de acordo com as observações da própria paciente antes das facetas definitivas e concluíram que essa etapa motivou a paciente e trouxe previsibilidade e segurança, tanto para ela quanto para o profissional. Bento et al. (2021) também utilizaram fotografias, enceramento e mock-up antes de confeccionar as facetas de um paciente com diastema.

O planejamento digital tem ganhado espaço. Silva, I. et al. (2021) consideraram o planejamento digital, feito a partir de fotos faciais e intraorais, um elemento fundamental para a precisão do diagnóstico e a previsibilidade do tratamento, especialmente quando associado ao enceramento. Silva, B. et al. (2021) o utilizaram para definir as medidas ideais dos dentes antes de uma cirurgia periodontal e das facetas, e Soares e Borges (2023) citaram seu uso para orientar o enceramento diagnóstico. Joshi (2025) mostrou que, em casos mais complexos, o planejamento precisa ser feito em etapas: no caso relatado, a paciente passou por tratamento das cáries, endodontia com clareamento interno e aumento de coroa antes das facetas.

O clareamento dental antes das facetas aparece em boa parte dos casos. Silva, I. et al. (2021) explicaram que ele deve ser sempre considerado nas reabilitações anteriores, por ser conservador e permitir associação com outros tratamentos, e que facilita a obtenção de um substrato mais claro, reduz o desgaste e permite uma camada mais fina de resina, com aspecto mais natural. Os mesmos autores alertaram, porém, que o resultado do clareamento nem sempre é previsível. Pereira et al. (2020) realizaram três sessões de clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% e aguardaram 21 dias para a estabilização da cor antes de escolher a cor da resina. Rocha et al. (2021) observaram que o clareamento prévio reduziu a necessidade de desgaste, e Reis et al. (2018), Bastos et al. (2018), Dias et al. (2020) e Bento et al. (2021) também realizaram o clareamento antes das facetas.

3.7 Técnica de confecção

3.7.1 Preparo e isolamento

Embora cada caso tenha suas particularidades, os artigos descrevem uma sequência de passos bastante semelhante. Lanzaretti et al. (2025) recomendaram uma profilaxia profissional completa dois dias antes do procedimento e, no dia do atendimento, a limpeza do dente com escova de nylon em baixa rotação e pasta de polimento. Alves, Peres e Lima (2022) e Lanzaretti et al. (2025) indicaram o isolamento absoluto com dique de borracha, e Oliveira et al. (2021) optaram por um isolamento absoluto modificado, com arco de Young, grampos e isolamento dos dentes vizinhos com fita própria para isso, para permitir o uso da guia palatina. Joshi (2025) também protegeu os dentes adjacentes com fita de teflon antes do condicionamento.

Quando há necessidade de preparo, ele deve ser o mais conservador possível. Dominguez et al. (2024) afirmaram que abordagens sem desgaste ou com preparo mínimo são preferíveis, que as margens precisam ser precisas para garantir boa adaptação e evitar infiltração, e que a oclusão deve ser analisada e ajustada antes, para garantir uma distribuição uniforme das forças. Alves, Peres e Lima (2022) descreveram, quando necessário, a redução vestibular e incisal com remoção das restaurações insatisfatórias e do tecido cariado. Vookanti et al. (2026) mantiveram o preparo mínimo, limitando o desgaste às áreas manchadas, com cerca de 0,5 a 0,75 mm no terço médio e 0,2 a 0,5 mm perto da margem gengival, e Dias et al. (2020) fizeram apenas um desgaste leve com pontas diamantadas de polimento.

3.7.2 Seleção de cor

A escolha da cor é uma das etapas mais delicadas. Dominguez et al. (2024) citaram como recursos as escalas de cores, os guias de cor e as fotografias digitais. Lanzaretti et al. (2025) e Vookanti et al. (2026) utilizaram a técnica do botão, em que pequenas porções de resina são polimerizadas sobre o dente para testar a cor, e Oliveira et al. (2021) usaram a mesma lógica, aplicando incrementos de resina nos terços cervical, médio e incisal sem condicionamento ácido. Silva, I. et al. (2021) explicaram que a seleção de cor pode ser feita por incrementos de resina

polimerizados na face vestibular, e Pereira et al. (2020) associaram a escala Vita à prova de incrementos, sob luz natural e após a estabilização da cor do clareamento.

3.7.3 Guia palatina e estratificação

Depois do condicionamento ácido e da aplicação do adesivo, a guia de silicone obtida do enceramento é posicionada para construir a parede palatina, que serve de base para o restante da faceta, como descreveram Oliveira et al. (2021), Pereira et al. (2020) e Lanzaretti et al. (2025). Cruz et al. (2023) explicaram que as facetas podem ser feitas à mão livre ou com guias de silicone ou acetato obtidas do modelo encerado, e que, nos dois casos, a resina é aplicada de forma estratificada e incremental, para reproduzir as características naturais do dente e reduzir os efeitos da contração de polimerização. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) utilizaram matriz transparente e cunha para auxiliar na construção das faces proximais.

Dominguez et al. (2024) definiram a estratificação como a aplicação de camadas sucessivas de resina com diferentes cores, opacidades e translucidez para imitar as características ópticas do dente, como translucidez, opalescência e fluorescência. Os autores diferenciaram a técnica de camada única, em que a resina é aplicada em uma só camada e esculpida, da técnica estratificada, com várias camadas, e destacaram a importância de reproduzir detalhes anatômicos como mamelos, sulcos e a translucidez da borda incisal. Silva, I. et al. (2021) orientaram que a resina de dentina seja aplicada no terço cervical e a de esmalte voltada para o terço incisal.

Lanzaretti et al. (2025) descreveram a sequência após a guia palatina: construção das paredes mesial e distal, estratificação vestibular para completar a anatomia e a cor, refinamento da forma com discos macios de granulação média e marcação das linhas de transição e dos sulcos de desenvolvimento com lápis colorido, antes do acabamento final. Pereira et al. (2020) utilizaram incrementos de resina para dentina e para esmalte, e Reis et al. (2018) combinaram a IPS Empress Direct, por sua menor opacidade, na dentina, com a Filtek Z350, pela facilidade de manipulação, no esmalte. Rocha et al. (2021) empregaram ainda resinas de efeito para reproduzir a opalescência e os detalhes típicos dos dentes jovens.

Em dentes muito escurecidos, a estratificação precisa de recursos extras. Falcão et al. (2023) aplicaram uma mistura fluida de três pigmentos opacificadores

sobre o dente 21, conferiram o valor da camada por fotografias em preto e branco e só então fizeram a estratificação com resina translúcida na palatina, resina de dentina opaca e resina acromática translúcida no esmalte, obtendo cor estável após sete meses. Vookanti et al. (2026), nos casos de fluorose, observaram que o próprio preparo removeu boa parte das manchas, dispensando o uso de opacificadores, e a faceta foi feita com resina nano-híbrida em camadas policromáticas.

3.8 Acabamento e polimento

O acabamento e o polimento são etapas que muitos autores colocam no mesmo nível de importância que a própria estratificação. Dominguez et al. (2024) afirmaram que essas etapas influenciam diretamente a estética, a durabilidade e a resistência ao manchamento das facetas, pois eliminam irregularidades e microasperezas que comprometem a aparência e favorecem o acúmulo de placa. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que, quando mal executadas, deixam porosidades, falta de brilho e alterações de cor, e que quanto mais lisa e polida a superfície, menor o risco de manchamento e de acúmulo de biofilme. Cruz et al. (2023) chegaram a listar o acabamento e o polimento mal feitos entre as falhas mais comuns na execução das facetas.

Silva, I. et al. (2021) explicaram que o acabamento remove os excessos e as irregularidades e refina os contornos anatômicos, enquanto o polimento confere brilho e reflexão de luz, deixando a superfície homogênea. Segundo esses autores, os excessos grosseiros são removidos com pontas diamantadas de acabamento, e os contatos oclusais devem ser conferidos em máxima intercuspidação, lateralidade e protrusão. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) acrescentaram que essa etapa diminui a rugosidade, evidencia os detalhes anatômicos e dá brilho à superfície.

Dominguez et al. (2024) relataram que pontas de borracha e discos de lixa são usados para remover excessos e alisar a superfície, enquanto pastas e escovas de polimento dão o brilho final, e que o tamanho das partículas abrasivas deve ser escolhido conforme a rugosidade inicial e o brilho desejado. Os instrumentos citados nos relatos seguem essa lógica. Alves, Peres e Lima (2022) citaram discos de óxido de alumínio e tiras de lixa, e Silva, I. et al. (2021) descreveram pontas abrasivas seguidas de discos de alto brilho e escovas de pelo de cabra. Pereira et al. (2020)

removeram os excessos com pontas diamantadas finas e extrafinas e poliram com borrachas de silicone, discos Sof-Lex e discos de feltro com pasta diamantada.

Oliveira et al. (2021) preferiram fazer o acabamento e o polimento sete dias depois do procedimento, com brocas multilaminadas, discos de granulação decrescente, kit de polimento, discos de feltro e pasta de polimento. Lanzaretti et al. (2025), por sua vez, fizeram novas fotografias sete dias após o tratamento, depois da reidratação dos dentes, para avaliar o resultado final.

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) observaram que o tipo de resina também interfere no resultado dessa etapa, já que as resinas microparticuladas e nanoparticuladas alcançam superfícies mais lisas, o que ajuda a explicar o melhor brilho e o menor manchamento observados por Irgang et al. (2020) nesse tipo de material. Para Soares e Borges (2023), a excelência nessas etapas finais é parte essencial do sucesso e da longevidade das facetas.

3.9 Facetas diretas e o periodonto

A saúde gengival é uma condição para o sucesso das facetas e, ao mesmo tempo, pode ser prejudicada por elas. Santos et al. (2022) realizaram uma revisão integrativa sobre o impacto das facetas diretas no periodonto, com base em cinco livros e 17 artigos publicados entre 2003 e 2021, e alertaram que o uso indiscriminado da técnica pode causar danos aos tecidos periodontais. Segundo os autores, as causas mais comuns de invasão do espaço biológico são restaurações mal adaptadas, lesões de cárie, preparos protéticos, perfurações, reabsorções radiculares e fraturas.

Santos et al. (2022) explicaram que a invasão do espaço biológico pode causar inflamação gengival, mesmo com bom controle de placa, sensibilidade gengival, recessão, formação de bolsa periodontal e reabsorção da crista óssea alveolar. Para evitar esses problemas, os autores defenderam que se mantenha uma distância média de 3 mm entre a crista óssea alveolar e a margem gengival, garantindo espaço para a margem da restauração sem agredir o periodonto. Cruz et al. (2023) também incluíram a invasão do espaço biológico entre as falhas de execução das facetas, e Brito, Ferreira e Yamashita (2022) lembraram que, quando bem feitas, as facetas diretas causam mínima agressão periodontal.

Cruz et al. (2021) relataram as consequências de não respeitar esses princípios: o paciente procurou atendimento insatisfeito com a cor das facetas antigas e com sangramento gengival durante a escovação. O tratamento incluiu clareamento imediato da arcada inferior, remoção das dez facetas existentes e confecção de dez novas facetas, e os autores concluíram que o respeito aos tecidos periodontais é indispensável para evitar retratamentos.

Em outros casos, a correção da gengiva faz parte do próprio tratamento. Silva, B. et al. (2021) realizaram gengivoplastia em uma paciente com grande exposição gengival e restaurações deficientes, após planejamento digital, e, noventa dias depois, fizeram o clareamento e as facetas do dente 15 ao 25, com grande impacto na autoestima da paciente. Lima, Amorim e Pereira (2023) associaram a gengivectomia em bisel interno às facetas em uma paciente com sorriso gengival e dentes curtos, explicando que a cirurgia remove o excesso de gengiva e aumenta a coroa clínica, enquanto as facetas devolvem forma, cor, opacidade e translucidez aos dentes. Nos dois trabalhos, os autores concluíram que a integração entre periodontia e dentística é essencial para um resultado harmônico e duradouro. Joshi (2025) também utilizou o aumento de coroa clínica para corrigir a assimetria gengival antes das facetas.

3.10 Longevidade, falhas e manutenção

3.10.1 Longevidade

A durabilidade das facetas diretas melhorou junto com a evolução dos materiais, mas os números variam entre os estudos. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) citaram trabalhos que estimam a longevidade das facetas diretas em cerca de 7 anos e outros que, com as resinas e os adesivos atuais, chegam a cerca de 10 anos. Santos et al. (2022) também relataram durabilidade clínica em torno de 10 anos, e Teixeira et al. (2022) afirmaram que vários estudos comprovaram a durabilidade dessas facetas por até sete anos. Irgang et al. (2020), em um estudo clínico que acompanhou facetas por até dez anos, encontraram taxa de sobrevivência de 77%.

A comparação com as facetas indiretas, no entanto, ainda divide os autores. Galvão et al. (2025) realizaram uma revisão sistemática, registrada no Prospero, nas bases PubMed, Embase e Cochrane, sem restrição de ano ou idioma, e incluíram

cinco estudos clínicos entre os 50 artigos encontrados. Em um dos estudos, as facetas diretas tiveram 98% de sobrevida e as indiretas, 87%; em outro, que acompanhou apenas facetas indiretas por dez anos, a sobrevida foi de 75%; e um estudo apenas com facetas diretas encontrou 87,5% de sobrevivência em dois anos e meio. Os autores concluíram que as facetas diretas em dentes anteriores parecem durar mais que as indiretas de resina, mas não puderam fazer uma análise quantitativa por causa das grandes diferenças entre os estudos.

Teixeira et al. (2022), por outro lado, revisaram estudos clínicos no PubMed e concluíram que as facetas indiretas de porcelana tiveram sobrevida relativamente maior e mais estabilidade de cor, embora as diretas permitam ajustar forma e cor com mais facilidade. Essa diferença pode ser explicada, em parte, pelo material comparado: no trabalho de Galvão et al. (2025), as facetas indiretas eram de resina; no de Teixeira et al. (2022), de porcelana. Dominguez et al. (2024) também observaram que, em comparação com as cerâmicas, as facetas de resina costumam ter menor durabilidade e maior taxa de fracasso a longo prazo, devido ao desgaste, ao manchamento e ao polimento deficiente.

3.10.2 Falhas

Quanto às falhas, os trabalhos apontam causas parecidas. Galvão et al. (2025) identificaram o descolamento e a fratura como os motivos mais frequentes nas duas técnicas. Cruz et al. (2023) concluíram que a principal causa das falhas é o desempenho do próprio cirurgião-dentista, citando anatomia inadequada, ausência de ponto de contato, acabamento e polimento mal executados, diferença de cor em relação aos dentes naturais e invasão do espaço biológico. Os autores explicaram que o preparo incorreto é um dos grandes responsáveis pelas fraturas por falhas coesivas e adesivas, e que o manchamento marginal, um dos problemas mais comuns das facetas diretas, é causado por defeitos de selamento.

Cruz et al. (2023) lembraram, no entanto, que fatores do paciente também contam, como forças oclusais, temperatura intraoral, variações de pH, higiene deficiente e hábitos parafuncionais, que podem levar ao descolamento e à fratura. Teixeira et al. (2022) destacaram que estudos anteriores encontraram margens cervicais lisas em apenas 15% das restaurações avaliadas, o que mostra como a adaptação marginal é um ponto crítico. Cruz et al. (2021) ilustraram bem esse

cenário, com facetas mal executadas que causaram sangramento gengival e precisaram ser totalmente refeitas.

Dominguez et al. (2024) descreveram como manejar essas complicações. Fraturas e descolamentos causados por trauma, forças oclusais excessivas ou falhas de adesão podem ser resolvidos com reparos localizados, substituição da faceta ou, em fraturas extensas, até tratamento endodôntico. As alterações de cor podem ser tratadas com polimento profissional, clareamento ou substituição, e os problemas oclusais, com ajustes, placas de proteção ou reconstrução das facetas. Os autores citaram ainda a sensibilidade pós-operatória como uma complicação comum, principalmente quando o preparo é mais invasivo. Dominguez et al. (2024) e Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) lembraram, inclusive, que a facilidade de reparo é uma vantagem da resina em relação à porcelana.

3.10.3 Manutenção

A manutenção depende muito da colaboração do paciente. Rocha et al. (2021) destacaram que a falta de higiene favorece a degradação da matriz orgânica da resina e a alteração de cor e textura, e por isso orientaram retornos semestrais para manutenção. Silva, I. et al. (2021) reforçaram que o profissional deve orientar o paciente sobre os hábitos alimentares que favorecem o manchamento e sobre a higienização correta, e consideraram esses cuidados fundamentais para a longevidade do material. Lima et al. (2020) também recomendaram retornos periódicos.

Dominguez et al. (2024) afirmaram que a frequência e a qualidade da higiene bucal influenciam a longevidade das facetas e que as visitas regulares ao dentista são essenciais para acompanhar a saúde e a integridade das restaurações ao longo do tempo. Tozo-Burgos, Escalante-Otárola e Sánchez-Tito (2025) reforçaram a importância das orientações sobre a dieta, já que bebidas ácidas degradam a superfície das resinas, e Teixeira et al. (2022) destacaram o uso da placa miorrelaxante em pacientes com bruxismo. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) concluíram que a durabilidade das facetas depende do material escolhido, da qualidade da execução e de fatores ligados ao próprio paciente.

REFERÊNCIAS

ALVES, D. L.; PERES, S. S. C.; LIMA, C. M. Faceta direta em resina composta: indicação e técnica. **Revista Cathedral**, v. 4, n. 1, p. 109-116, 2022.

BASTOS, N. A. et al. Clinical performance of the composite resin veneers: the minimally invasive approach. **Archives of Health Investigation**, v. 7, n. 9, p. 392-396, 2018. DOI: 10.21270/archi.v7i9.3151.

BENTO, M. J. et al. Impacto psicossocial na reabilitação estética anterior com resina composta direta: relato de caso. **Archives of Health Investigation**, v. 10, n. 2, p. 209-214, 2021. DOI: 10.21270/archi.v10i2.5083.

BRITO, J. A. O.; FERREIRA, V. S.; YAMASHITA, R. K. Indicações e longevidade das facetas de resina composta: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, e467111335738, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35738.

CRUZ, A. I. et al. Troca de facetas em resina composta insatisfatórias, buscando adequação anatômica e estética: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e169101421740, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.21740.

CRUZ, K. F. et al. As principais falhas na execução de facetas em resina composta em dentes anteriores: revisão de literatura. **Revista Cathedral**, v. 5, n. 3, p. 75-86, 2023.

DIAS, P. et al. Aesthetic restoration using composite resin in teeth with inactive carious lesions: a conservative and predictable approach. **RGO: Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 68, e20200052, 2020. DOI: 10.1590/1981-86372020000522018010l.

DOMINGUEZ, G. P. et al. Facetas diretas em resina composta: uma revisão abrangente. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 7, e12213746470, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i7.46470.

FALCÃO, A. et al. Faceta direta de resina composta utilizando pigmentos opacificadores para reabilitação estética anterior de dente escurecido: relato de caso. **Revista Naval de Odontologia**, v. 50, n. 1, p. 15-20, 2023.

FERNANDES, L. K. P. et al. O método de fotopolimerização é capaz de influenciar nos valores de microdureza das resinas compostas? Um estudo in vitro. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 51, e20220043, 2022. DOI: 10.1590/1807-2577.04322.

GALVÃO, B. W. L. et al. Longevidade clínica das facetas diretas e indiretas em resina composta em dentes anteriores: uma revisão sistemática. **RSBO**, v. 22, n. 2, p. 308-321, 2025.

IRGANG, L. et al. A clinical evaluation of direct veneers made with two types of composites. **Journal of Research in Dentistry**, v. 8, n. 1, p. 10-16, 2020. DOI: 10.19177/jrd.v8e1202010-16.

JOSHI, S. Aesthetic smile makeover with direct resin composite veneers: a case report. **Scientiarum: A Multidisciplinary Journal**, v. 1, n. 5, p. 1-5, 2025. DOI: 10.54646/SAPARS.2025.22.

KORKUT, B.; YANIKOĞLU, F.; GÜNDAY, M. Direct composite laminate veneers: three case reports. **Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects**, v. 7, n. 2, p. 105-111, 2013. DOI: 10.5681/joddd.2013.019.

LANZARETTI, G. et al. Esthetic smile rehabilitation with direct composite veneers: a narrative review with a practical explanation of the technique. **Minerva Dental and Oral Science**, v. 74, n. 4, p. 266-272, 2025. DOI: 10.23736/S2724-6329.25.05161-7.

LIMA, A. P. M.; AMORIM, J. C.; PEREIRA, T. S. Reabilitação estética anterior com gengivectomia e facetas em resina composta. **Scientia Generalis**, v. 4, n. 2, p. 93-103, 2023. DOI: 10.22289/sg.V4N2A7.

LIMA, H. E. R. et al. Fechamento de diastema utilizando resina composta. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 95036-95045, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n12-115.

NALBANDIAN, S.; MILLAR, B. J. The effect of veneers on cosmetic improvement. **British Dental Journal**, v. 207, E3, 2009. DOI: 10.1038/sj.bdj.2009.609.

OLIVEIRA, L. M. O. et al. Fechamento de diastema pela técnica direta em resina composta: relato de caso clínico. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, e431101624060, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.24060.

PEREIRA, M. R. et al. Reabilitação estética com resina composta em paciente jovem: relato de caso clínico. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 29, n. 88, p. 24-28, 2020.

REIS, G. R. et al. Mock-up: previsibilidade e facilitador das restaurações estéticas em resina composta. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 27, n. 81, p. 105-111, 2018.

ROCHA, A. O. et al. Intervenção estética anterior por meio de facetas diretas em resina composta: relato de caso. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, e6439, 2021. DOI: 10.25248/REAS.e6439.2021.

SANTOS, R. G. et al. O impacto das facetas diretas em resina composta sobre o tecido periodontal: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, e54511730235, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30235.

SILVA, B. J. et al. Transformação de sorriso envolvendo cirurgia plástica periodontal e facetas em resina composta: relato de caso. **Revista Odontológica Integrativa do Centro-Oeste**, v. 1, n. 1, p. 75-86, 2021.

SILVA, I. B. et al. Facetas diretas em resina composta: uma abordagem conservadora (revisão da literatura). **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 109291-109307, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n11-518.

SOARES, I. S.; BORGES, T. S. Técnicas e indicações para a realização das facetas em resina composta direta: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 6, e3312641962, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i6.41962.

TEIXEIRA, B. C. et al. Longevidade de tratamento reabilitador com facetas diretas e indiretas em dentes anteriores: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, e409111537369, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37369.

TOZO-BURGOS, J. G.; ESCALANTE-OTÁROLA, W.; SÁNCHEZ-TITO, M. Erosive resistance of high-translucency resin composites: new insights for esthetic dentistry. **Journal of Clinical and Experimental Dentistry**, v. 17, n. 12, p. e1508-e1516, 2025. DOI: 10.4317/jced.63433.

VAZ, M. M.; LOPES, G. F.; TOLEDO NETA, M. E. Tratamento reabilitador estético como uma possibilidade para pequenas correções de alinhamento. **Revista Odontológica Integrativa do Centro-Oeste**, v. 2, n. 1, p. 28-42, 2022.

VOOKANTI, V. R. R. et al. Aesthetic transformation of fluorosed teeth using minimally invasive direct composite veneers: a case report. **University Journal of Dental Sciences**, v. 12, n. 1, p. 91-96, 2026. DOI: 10.21276/ujds.2026.12.1.17.